جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ضحى احمد محمد اسماعيل
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** المعصره **العنوان :** المعصرة
رقم البطاقة : 27811150106044 **رقم التليفون :** 01157438422 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-11-1978 **المهنة :** حاصل علي بكالوريوس

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض بالصبغه [11127] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ضحى احمد محمد اسماعيل
National ID: 27811150106044

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ضحى
احمد محمد اسماعيل
٢٧ ش الجندى حدائق حلوان
المعصره - القاهره

٢٧٨١١١٥٠١٠٦٠٤٤

IU8648077



٢٧٨١١١٥٠١٠٦٠٤٤ ٢٠٢١/٠٣
حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية
انثى مسلمة متزوجة
خالد محمد شاكر زكى الشابورى
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٣/١٤

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Name: ضحي احمد محمد اسماعيل **MR. :** 3366	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was evaluated for severe back pain and a request for a bone scan while on ARIMIDEX.

A bone scan performed on 25 March demonstrated tracer uptake at L5/Sacrum and the right sacroiliac articulation, prompting recommendation for MRI; the patient was continued on ARIMIDEX and calcium supplementation, with a plan for ZOLADEX 10.8 SC on 22 April and full laboratory workup.

The treatment plan was updated to include ARIMIDEX plus supplementation, with ZOLADEX scheduled for a three-month interval on 15 July, and the pharmacy was instructed to prepare the medication for the next visit on 23 August. The current status is that the patient remains on ARIMIDEX with planned ZOLADEX administration.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

MDT form

Female

Referral Age: 45 Y

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
CAP CT: no mets-axillary LN

ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
8/8	7/8	0		

T	N	M
3	3	0

Sonomammiography

PATIENT HISTORY
locally advanced Rt. breast cancer
received EC x3 + taxotere x2 only then lost FU last on 2/5/2023
new CAP CT: stationary, no mets

MDT OUTCOME & PLAN

Pt. lost FU for 7 months (refused surgery), now showing mild disease progression.
After extensive pt. counselling pt. agreed to Rt. MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name :
Patient No. : 2781115010004
Lab No. : 640/24
Sex : Female
Age : 45 Y
Referring Doc :

Request No : 13007672
Request Date : 17/02/2024
Verification Date : 04/03/2024
Financial Category :
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer post NACT
Nature Specimen: Right modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination
- Procedure: Right MRM measured 22x18x8cm with covering skin ellipse measured 18x11cm
- Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- Size: 7x5x4 cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 1.5 cm away from deep margin.
- Lymph nodes number and size: 12 L.Ns up to 1.7x1.3cm.

Microscopic Examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+ 1) Grade II.
- Maximal tumor diameter 7cm
- Actual tumor cellularity: 50%, tumor necrosis index: 50%
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free
- Lymph node involvement: Metastatic deposits 6/12
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathological partial response
- Microcalcifications: No

Diagnosis:
Right breast cancer post NACT, MRM specimen:
Invasive duct carcinoma, grade II.

Verified by :
Dr Mohamed Torky

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name : [illegible]
National ID : 27811150106224
Lab No : 646/24
Sex : Female
Age : 45 Y
Referring Doc :

Request No. : 13007672
Request Date : 17/02/2024
Verification Date : 04/03/2024
Financial Category : [illegible]
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

- Maximal tumor diameter: 7cm
- Actual tumor cellularity: 50%, tumor necrosis index: 50%
- Resection Margins: Free
- Skin: Free
- Lymph nodes: Metastatic deposits 6/12
- Histologic response to therapy: Pathological partial response
- Stage: ypT3, ypN2
- RCB: 4.472 RCB class III

Signature
Dr.Rana Fathy
Dr.Muhammad Torkey

Verified by :
Dr.Mohamed Torky

Room No.(1) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mnyr El Qadema - Cairo, Egypt
غرفة رقم (1) - الدور الأول - مبنى رقم 987 - كورنيش النيل - منير القديمة - القاهرة

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: [illegible]	Request No.	: 13000993
Patient No.	: 27811150106044	Request Date	: 23/11/2022
Path No.	: 3530/22	Verification Date	: 05/12/2022
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible]
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA
Right breast mass

NATURE OF SPECIMEN
Tru cut biopsy, collected at 23/11/2022 , 1.19 pm

GROSS EXAMINATION
Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm , totally submitted.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2. ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

MICROSCOPIC EXAMINATION
* Histological type: Invasive lobular carcinoma .
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+2) Grade II
* LCIS: Focal
* Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy.
* Perineural invasion: No.
IPT:
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (Allred score 7/8)
Her-2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
Ki 67: 12 % nuclear reaction in tumor cells

DIAGNOSIS
Right breast mass , Tru cut biopsy.
Invasive lobular carcinoma, Grade II with focal LCIS.
IHC

Verified by :
Dr Marwa mahmoud

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	[illegible]	Request No.	13000993
Patient No.	27811150106044	Request Date	23/11/2022
Path No.	3530/22	Verification Date	05/12/2022
Sex	Female	Financial Category	[illegible]
Age	44 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.			

Registered by marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

ER: Positive (score 8/8)
PR: Positive (score 7/8).
HER-2: Negative (score 0)
K-67: Positive in 12% of tumor cells

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar
Dr. Ameen Ahmed

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

Patient Name: Doha Ahmed Mohamed Ismail	Date : 18/12/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 44 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 25393

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Prominent right axillary lymph nodes are noted the larges it seen measuring about 1.4 x 0.9 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture. Right hepatic lobe segment V focal lesion is seen showing irregular nodular peripheral enhancement which filled in the delayed phase measuring about 3.8 x 2.7 cm. Another smaller enhanced lesion is seen in segment VI measuring about 7 mm in diameter, likely representing hemangioma.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic billary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

Patient Name: Doha Ahmed Mohamed Ismail	Date : 18/12/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 44 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 25393

- No abdominal or pelvic collections.

Opinion:

- Known case of breast cancer showing prominent right axillary lymph nodes.
- No pulmonary metastatic deposits.
- Right hepatic lobe focal lesions likely representing hemangioma.

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc
Dr. M. Gomaa, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

جوستاف روسي

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

09/29/2026

MDT FORM

Name:	Doha El-Sayed Mohamed Ismail	**MRN:**	3366
Age:	48 Y	**ID:**	27811150106044
Menopausal Sta	PRE	**Phone:**	
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
CO Morbidity:	HTN	**Reason Of MDT:**	PT BACOME METASTATIC

Clinical Data:

BX: IDC G2

ER: 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** 0 **KI67:**

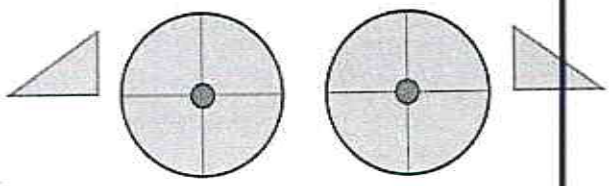
Sonomammography:

Mets Workup:

History:

A CASE OF LOCALLY ADVANCED RT BREAST CANCER DIAGNOSED 2023
RECEIVED NACT (EC , TXT LAST ONE 5/2023) THEN LOST FU TILL 1/2024 AS PT WAS REFUSING SURGERY THEN PT UNDERWENT RT MRM 2/2026
PATHOLOGY IDC G2
YPT3 N2M0
PT RECEIVED PORTH THEN STARTED HT AI ZOLADEX SINCE 4/2024 TILL 9/2026
NEW CT CAP 7/2026
2 HFLs and metastatic subpleural pulmonary nodules
NB bone scan requested TODAY

R L



TNM

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

For Palbociclib + Fulvestrant + Zoladex
Fup Bone scan if positive --> add Zometa

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د خالد عبد العزيز	د محمد شيراوي				

[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]
Non-HIO Letter

جوستاف روسي
انترناشونال

إسم المريض ثلاثي: .....
رقم الملف: .....

تقرير طبي

السيد/ .....

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من ..... بشان تقرير طبي للمريض: ضحى أحمد محمد ا
بقسم ..... رقم طبي .....
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :
تاريخ وساعة الدخول ..... تاريخ وساعة الخروج .....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

عاجل
لعمل Breast Coder for
سي CT Chest, abdomen/
فط Pelvis with Contrast
الفرق اذا with Comparison last
كان قبل اشع study
استة معطيه مع الصور
والفحص والفحوصات الصبغه
المقارنة مع الاشعه
السابقه

تحريرا في

الوقت: ..... التاريخ : / /

الطبيب المعالج
.....

يعتمد ،،

٢٠٢١/١١/٠٦